

TEMA 7.24 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos de la Alimentación: Anorexia y Bulimia Nervosa

PERFIL EUNACOM 1.02.1.018

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los **Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)** son patologías psiquiátricas frecuentes y potencialmente graves, especialmente la anorexia nervosa. El diagnóstico es fundamentalmente **clínico** y el manejo debe ser siempre **multidisciplinario**, involucrando psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, médicos de cabecera y el apoyo del entorno familiar.

Enfoque General del Tratamiento

El tratamiento no se limita a una dieta; requiere un abordaje integral:

- **Dieta y nutrición:** Es el pilar básico para recuperar un estado biológico funcional. - **Psicoterapia:** Enfocada en la autoestima y el miedo a la obesidad (Anorexia) o en el control de impulsos (Bulimia). - **Farmacoterapia:** Utilizada como apoyo para síntomas ansiosos, depresivos o de impulsividad. - **Manejo familiar:** Esencial para el soporte y la supervisión de las conductas alimentarias en el hogar.

Anorexia Nervosa

Se caracteriza por una búsqueda patológica de la delgadez y una restricción severa de la ingesta.

Clínica y Criterios Diagnósticos

1. **Bajo peso:** Es un criterio obligatorio. El paciente debe estar en rango de desnutrición (habitualmente IMC < 18.5 kg/m²). 2. **Restricción de la ingesta:** Conductas activas para evitar ganar peso. 3. **Alteración de la percepción corporal:** El paciente se autopercibe con sobrepeso u obesidad a pesar de su desnutrición evidente. 4. **Miedo intenso a ganar peso:** Incluso estando en infrapeso.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Amenorrea: La desnutrición severa en la anorexia produce una **amenorrea de tipo hipotalámica**. No es un problema ovárico ni hipofisario primario, sino una respuesta adaptativa del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal ante la falta de energía.

Complicaciones y Estudio

La anorexia conlleva un riesgo vital elevado. Se asocia frecuentemente al **Trastorno de Personalidad Obsesivo-Compulsivo** (perfil controlador y perfeccionista). - **Osteoporosis:** Por el déficit estrogénico y nutricional. - **Daño Hepático Crónico:** Alteraciones en las pruebas hepáticas por desnutrición calórica. - **Estudio necesario:** Se debe solicitar **Densitometría Ósea** y **Pruebas Hepáticas** a toda paciente con diagnóstico de anorexia.

Manejo de la Anorexia

- **Abordaje:** No debe ser hostil ni crítico. Se debe comunicar preocupación y deseo de apoyo. - **Hospitalización:** Se indica si hay riesgo vital, desnutrición extrema (IMC < 15), alteraciones hidroelectrolíticas graves o fracaso del tratamiento ambulatorio. - **Fármacos:** Los **Antidepresivos (ISRS)** ayudan con la ansiedad y comorbilidades. En casos graves con negativa extrema a comer, se pueden usar **antipsicóticos** para control conductual.

Bulimia Nervosa

Se caracteriza por episodios de descontrol alimentario seguidos de conductas compensatorias.

Clínica y Criterios Diagnósticos

1. **Atracones:** Ingesta de una cantidad de comida superior a lo normal en un periodo corto, con sensación de pérdida de control. 2. **Purga (Conductas compensatorias):** Acciones para evitar el aumento de peso, como vómitos autoinducidos, uso de laxantes, ejercicio excesivo o ayunos prolongados. 3. **Frecuencia:** Los episodios deben ocurrir con cierta regularidad (generalmente al menos una vez por semana por 3 meses). A diferencia de la anorexia, los pacientes con bulimia suelen tener **peso normal, sobrepeso u obesidad**. Se asocia frecuentemente al **Trastornos de Personalidad** de tipo **Límite (Borderline)**, debido a la impulsividad.

Complicaciones de la Purga

TABLA 7.24.1: COMPLICACIÓN VS DESCRIPCIÓN	
COMPLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Parotidomegalia	Aumento de tamaño de las glándulas salivales por el estímulo del vómito recurrente.
Síndrome de Mallory-Weiss	Hematemesis (vómito con sangre) tras esfuerzos de vómito, debido a un desgarramiento en la unión esofagogástrica.
Síndrome de Boerhaave	Perforación esofágica por vómitos violentos. Es una urgencia quirúrgica (dolor torácico, mediastinitis y shock).
Alteraciones dentales	Erosión del esmalte dental por el ácido gástrico.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **Síndrome de Boerhaave** es una complicación potencialmente mortal. Ante un paciente con bulimia que presenta dolor torácico súbito y fiebre tras vomitar, se debe sospechar perforación esofágica.

Manejo de la Bulimia

- El manejo es habitualmente **ambulatorio**. - **Farmacoterapia:** Los **ISRS (especialmente Fluoxetina)** a dosis altas han demostrado utilidad para reducir la frecuencia de los atracones y las purgas.

Diferencias Clave: Anorexia vs. Bulimia

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El elemento diferenciador fundamental entre ambos trastornos es el **PESO**. - Si el paciente tiene un **IMC muy bajo (desnutrición)**, el diagnóstico es **Anorexia** (aunque tenga atracones o purgas, se clasifica como Anorexia de tipo purgativo). - Si el paciente tiene un **peso normal o elevado**, el diagnóstico es **Bulimia**.

Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria

Es importante reconocer la existencia de otras variantes clínicas:

- **Trastorno de Masticar y Escupir:** El paciente saborea la comida, la mastica, pero no la traga.
- **Trastorno de Rumiación:** Regurgitación repetida de los alimentos (vuelven a la boca) para volver a masticarlos, tragarlos o escupirlos.
- **Síndrome de Gourmand (Goodmedt):** Preocupación excesiva por consumir solo comidas extremadamente elaboradas, elegantes o caras, generando angustia si no se tiene acceso a ellas.
- **Vigorexia (Dismorfia Muscular):** Aunque técnicamente es un trastorno dismórfico corporal, se relaciona con la conducta

alimentaria y el ejercicio. El individuo se percibe débil o pequeño a pesar de ser muy musculoso, dedicando su vida al gimnasio y dietas hiperproteicas extremas.

Resumen de Comorbilidades y Exámenes

- **Psiquiátricas:** Depresión, Trastornos Ansiosos y **Trastornos de Personalidad**. - **Orgánicas:** - Electrolitos plasmáticos (buscar hipokalemia por vómitos/laxantes). - ECG (riesgo de arritmias por alteraciones iónicas). - Densitometría ósea. - Pruebas hepáticas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 17 años, talla 1.70 m y peso 40 kg, consulta porque "se ve muy gorda". Come muy poco y recientemente ha vomitado después de comer para "no subir de peso". Tiene amenorrea de 4 meses.

¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos de la Alimentación: Anorexia y Bulimia Nervosa. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Anorexia nervosa: bajo peso + restricción + percepción corporal distorsionada (se ve obesa). Se asocia al TPOC.
- Bulimia nervosa: atracones (pérdida de control) + purga (vómitos, laxantes, ejercicio). Peso normal o con sobrepeso. Se asocia al TPL.
- El elemento diferenciador anorexia vs bulimia: el bajo peso define la anorexia; la pérdida de control sobre la ingesta define la bulimia.
- Complicaciones de la anorexia: osteoporosis (densitometría ósea obligatoria) y daño hepático (pruebas hepáticas obligatorias).
- Complicaciones de la bulimia por vómitos repetidos: síndrome de Mallory-Weiss (hematemesis) y síndrome de Boerhaave (perforación esofágica + mediastinitis).
- La anorexia puede requerir hospitalización por riesgo vital (desnutrición severa); la bulimia habitualmente se maneja ambulatoriamente.
- Amenorrea en anorexia: es de tipo hipotalámica (por desnutrición), diferente de la amenorrea ovárica o hipofisiaria.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN: ANOREXIA Y BULIMIA NERVOSA)

PREGUNTA 1

Mujer de 17 años, talla 1.70 m y peso 40 kg, consulta porque "se ve muy gorda". Come muy poco y recientemente ha vomitado después de comer para "no subir de peso". Tiene amenorrea de 4 meses. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Bulimia nervosa
- B) Anorexia nervosa de tipo restrictivo-purgativo
- C) Bulimia nervosa con anorexia comórbida
- D) Amenorrea hipotalámica; solo tratamiento ginecológico
- E) Trastorno dismórfico corporal; cirugía estética

PREGUNTA 2

Mujer de 22 años con peso normal refiere que periódicamente "no puede parar de comer" y se come varios paquetes de galletas de una vez. Después se siente muy culpable y se induce el vómito. ¿Qué complicación de esta conducta puede ser potencialmente mortal?

- A) Osteoporosis por mal estado nutricional
- B) Síndrome de Boerhaave: perforación esofágica por vómitos repetidos con mediastinitis
- C) Daño hepático crónico
- D) Diabetes insípida nefrogénica
- E) Hipoglicemia por ayuno prolongado

PREGUNTA 3

Médico de urgencias evalúa a una paciente de 16 años con anorexia nervosa severa. Su peso es 35 kg para 1.65 m, tiene FC 45 lpm, está somnolienta y no colabora con el tratamiento. ¿Cuál es la conducta?

- A) Manejo ambulatorio con nutricionista y psicóloga
- B) Hospitalización urgente para realimentación y estabilización, con apoyo multidisciplinario
- C) Solo antidepresivos ISRS y psicoterapia ambulatoria
- D) Dar el alta con indicaciones de alimentación y control en 1 semana
- E) Iniciar antipsicótico oral para manejo de la conducta restrictiva

RESUMEN: TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN: ANOREXIA Y BULIMIA NERVOSA

Los trastornos de la alimentación son patologías frecuentes y graves, especialmente la anorexia nervosa. El diagnóstico de todos es clínico y el tratamiento es multidisciplinario (médico, psiquiátrico, psicológico, nutricional y familiar). La anorexia nervosa se caracteriza por: bajo peso (en rango de desnutrición), restricción de la ingesta, preocupación excesiva por el peso y alteración de la percepción corporal (se ve obesa siendo delgada). La amenorrea hipotalámica puede acompañar el cuadro pero no es diagnóstica. Se asocia al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Las complicaciones incluyen osteoporosis (densitometría ósea obligatoria) y daño hepático crónico (pruebas hepáticas obligatorias). El tratamiento incluye restauración del peso, psicoterapia (manejo del autoestima y el miedo a la obesidad), y eventualmente antidepresivos ISRS o antipsicóticos en casos graves. La hospitalización se considera cuando hay desnutrición severa con riesgo vital. La bulimia generalmente se maneja ambulatoriamente. La bulimia nervosa se caracteriza por episodios de atracones (pérdida del control sobre la ingesta) seguidos de purga (vómitos, laxantes, ejercicio excesivo, ayuno). El peso suele ser normal o con sobrepeso (diferencia fundamental con la anorexia). Se asocia al trastorno de personalidad límite. Las complicaciones incluyen parotiditis, síndrome de Mallory-Weiss (hematemesis por desgarro esofágico por vómitos repetidos) y síndrome de Boerhaave (perforación esofágica por vómitos, que se manifiesta con dolor torácico y mediastinitis). El tratamiento incluye antidepresivos ISRS y psicoterapia (manejo de la impulsividad y el autocontrol). El elemento diferenciador fundamental entre anorexia y bulimia es el control sobre la ingesta: la anorexia restringe (controla), la bulimia pierde el control (atracones); el bajo peso define la anorexia.